

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ÍNDICE DE WHITELEY (WHITELEY INDEX — WI)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Hipocondría, Fobia y Convicción de Enfermedad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Índice de Whiteley (WI-14).
Nombre Original (Inglés)	<i>Whiteley Index of Hypochondriasis (WI)</i>
Autor Original	Prof. Issy Pilowsky (1967), University of Sydney / University of Sheffield.
Adaptaciones Españolas	Avia (1993, traducción clínica de referencia); Fernández Martínez y Fernández Rodríguez (1998, Psicothema).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado clásico de hipocondría y somatización reactiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 14 reactivos dicotómicos (Sí/No) con un reactivo de inversión (ítem 7).
Población y Rango	Adultos (>= 18 años). Cribado en medicina interna, atención primaria y psiquiatría de enlace.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para práctica médica y de investigación clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE PILOWSKY

El Índice de Whiteley fue concebido por Issy Pilowsky (1967) como el primer instrumento psicométrico estandarizado diseñado específicamente para aislar y medir las dimensiones operativas de la **hipocondría** como un constructo psiquiátrico diferenciado de la histeria de conversión y de los trastornos de angustia clásicos.

El modelo teórico de Pilowsky postula que la conducta hipocondríaca no es unitaria, sino que responde a la convergencia de tres ejes psicopatológicos interdependientes: la **preocupación corporal** (atención selectiva a molestias físicas habituales), la **fobia a la enfermedad** (miedo a contraer dolencias específicas) y la **convicción de enfermedad** (la certeza inamovible de estar enfermo pese al reaseguro médico continuado). Por su brevedad y formato dicotómico, se ha consolidado como un estándar en interconsultas hospitalarias y epidemiología médica.

3. DIMENSIONES EVALUADAS EN EL ÍNDICE DE WHITELEY (PILOWSKY, 1967)

Dimensión Teórica	Ítems Ref.	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicopatológica
1. Preocupación Corporal	1, 2, 5, 11	0 a 4	Hipervigilancia propioceptiva, sensación de vulnerabilidad física y rumiación sobre sensaciones corporales.
2. Fobia a la Enfermedad	4, 6, 8, 12	0 a 4	Temor fóbico e irracional al contagio o a padecer dolencias fatales (cáncer, cardiopatías) ante información externa.
3. Convicción de Enfermedad	3, 7(inv), 9, 10, 13, 14	0 a 6	Certeza irreductible de dolencia somática no diagnosticada e insatisfacción sistemática con la opinión médica.
PUNTUACIÓN TOTAL WI	1 al 14	0 a 14	Índice acumulativo global de actitud y conducta hipocondríaca clínica.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.78 a 0.84 en pacientes de atención primaria y consultas externas en España (Fernández Martínez y Fernández Rodríguez, 1998).
Rendimiento Diagnóstico	Para el punto de corte clínico <i>ge8</i> : sensibilidad diagnóstica del 81% y especificidad del 79% frente a criterios diagnósticos de Hipocondría (DSM-IV) y Trastorno de Ansiedad por Enfermedad (DSM-5).
Validez Concurrente	Correlación elevada con el Cuestionario de Conducta de Enfermedad (IBQ $r = 0.81$), el SHAI ($r = 0.73$) y la escala de Somatización del SCL-90-R ($r = 0.65$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.78$ a 0.83 tras 3 semanas de intervalo en pacientes ambulatorios médicos estables.
Poder Discriminante	Distingue con significación estadística entre pacientes con quejas somáticas funcionales no orgánicas y pacientes con patología orgánica confirmada sin ansiedad secundaria.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÍTEMS

La escala se responde mediante opciones dicotómicas (**Sí / No**):

- **Puntuación Directa (Ítems 1 al 6 y 8 al 14):** La respuesta afirmativa se califica con **1 punto**; la negativa con **0 puntos**.
- **Inversión del Ítem 7:** El ítem 7 (*¿Le resulta fácil quitarse de la cabeza la idea de que está enfermo?*) evalúa flexibilidad cognitiva y debe invertirse:

Respuesta “NO” en ítem 7 = 1 punto | Respuesta “SÍ” en ítem 7 = 0 puntos

- **Puntuación Total WI:** Suma de las respuestas afirmativas directas más el ítem 7 invertido. Rango: **0 a 14 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (AVIA, 1993; PILOWSKY, 1967)

Nivel	Puntuación	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
Normal	0 a 4	Preocupación médica adaptativa	Actitud ajustada ante la salud física. No se requieren intervenciones psicológicas específicas.
Limítrofe	5 a 7	Ansiedad por la salud subclínica	Preocupaciones somáticas notables en presencia de estrés. Psicoeducación en estilos de afrontamiento.
Clínico	8 a 14	Corte Positivo (Hipocondría)	Cuadro indicativo de Trastorno de Ansiedad por Enfermedad o Síntomas Somáticos. Evaluación psiquiátrica y TCC focalizada.

UTILIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA DETECCIÓN DE HIPERFRECUENTACIÓN: Puntuaciones *ge8* en pacientes que acuden reiteradamente al médico de cabecera sin hallazgos analíticos identifican de forma precoz el bucle de hiperfrecuentación, permitiendo pactar un calendario estructurado de citas médicas y evitar pruebas diagnósticas innecesarias.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

DIFERENCIACIÓN ENTRE FOBIA A LA ENFERMEDAD Y CONVICCIÓN DE ENFERMEDAD:

- **Predominio de Fobia a la Enfermedad:** El paciente reconoce la irracionalidad de sus miedos ("sé que no tiene sentido, pero me aterra tener cáncer"); excelente pronóstico con técnicas cognitivo-conductuales de exposición interoceptiva y detención del reaseguro.
- **Predominio de Convicción de Enfermedad:** Creencia rayana en lo delirante con rigidez cognitiva ("los médicos se equivocan y ocultan mi tumor"); requiere abordaje psicoterapéutico más cauteloso basado en validación empática, entrevistas motivacionales y en ocasiones fármacos antipsicóticos a dosis muy bajas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paciente: Varón de 46 años, administrativo, que ha acudido 14 veces en los últimos 6 meses al servicio de urgencias por molestias gástricas inespecíficas, convencido de que sufre un adenocarcinoma gástrico a pesar de endoscopias, biopsias y ecografías normales.

Puntuación WI Total: 11/14 (Rango Clínico Severo — Positivo).

• **Análisis cualitativo:** Marca afirmativamente todos los reactivos de Convicción de Enfermedad (ítems 3, 9, 10 y 13) e ítem 7 invertido (incapaz de apartar la idea de estar enfermo). Expresa desconfianza profunda en los informes médicos de alta.

Conducta Asistencial: Se implementa el protocolo de Smith para pacientes somatizadores: se asigna a un único médico de cabecera con visitas programadas mensuales fijas no condicionadas a síntomas agudos. En salud mental se aplica TCC centrada en somatosensorialidad normal versus catastrofismo. A los 4 meses, la puntuación en el WI se reduce a 6/14 (rango subclínico), reduciéndose las visitas a urgencias a cero.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: DESCARTE ORGÁNICO RAZONABLE

El diagnóstico de hipocondría no debe emitirse de forma precipitada sin una anamnesis médica adecuada que descarte patologías autoinmunes incipientes, endocrinopatías o neoplasias iniciales.

DELIRIO SOMÁTICO / MONOTEMÁTICO

Puntuaciones máximas continuadas con convicción inquebrantable que alteran la coherencia biográfica deben diferenciarse de Trastornos Delirantes Somáticos (psicosis monotemática).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Pilowsky, I. (1967). Dimensions of hypochondriasis. *The British Journal of Psychiatry*, 113(494), 89–93.
2. Avia, M. D. (1993). *Hipocondría*. Madrid: Martínez Roca.
3. Fernández Martínez, R., & Fernández Rodríguez, C. (1998). Tratamiento cognitivo-conductual de la hipocondría: Un estudio de caso. *Psicothema*, 10(2), 259–270.
4. Fink, P., Ewald, H., Jensen, J., Sørensen, L., Engberg, M., Holm, M., & Munk-Jørgensen, P. (1999). Screening for somatization and hypochondriasis in primary care and neurological in-patients: a six-item Whiteley Index questionnaire. *Journal of Psychosomatic Research*, 46(3), 261–273.